

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

TOP-8 · TREATMENT OUTCOME PTSD SCALE

Escala de 8 ítems para los Resultados del Tratamiento del TEPT de Davidson – Medida clínica abreviada, sensible al cambio y de monitorización longitudinal

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Treatment Outcome PTSD Scale (TOP-8)
Nombre en español	Escala de 8 Ítems para los Resultados del Tratamiento del TEPT
Sigla oficial	TOP-8
Autores originales	Jonathan R. T. Davidson y James T. Colket (1997)
Adaptación hispanohablante	Julio Bobes et al. (2000, 2004); Banco de Instrumentos Básicos / CIBERSAM
Año de publicación original	1997 (derivada de la Davidson Trauma Scale; validación española en 2000)
Constructo primario	Severidad y cambio sintomático en los síntomas nucleares más sensibles al tratamiento del TEPT
Formato de administración	Heteroaplicada por clínico o profesional de la salud mental con escala Likert de 5 puntos (0 a 4)
Población diana	Pacientes adultos diagnosticados de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en tratamiento activo
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (8 ítems referidos a la última semana)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto con fines asistenciales y académicos respetando autoría

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Treatment Outcome PTSD Scale** (TOP-8) fue desarrollada por Jonathan R. T. Davidson y James T. Colket en el Duke University Medical Center con el propósito explícito de resolver un desafío logístico en los ensayos clínicos farmacológicos y en la práctica psicoterapéutica: la necesidad de un instrumento de evaluación del Trastorno por Estrés Postraumático que fuera extremadamente rápido de administrar pero que retuviera la máxima sensibilidad al cambio terapéutico. Las entrevistas exhaustivas como la CAPS-5, aunque excelentes para el diagnóstico basal, resultan inviables para el seguimiento semanal o quincenal rutinario.

Mediante análisis psicométricos rigurosos sobre grandes cohortes de pacientes tratados con sertralina y fluoxetina, Davidson y Colket identificaron los 8 ítems de la **Davidson Trauma Scale (DTS)** que exhibían el mayor poder discriminativo y la mayor magnitud de cambio estadístico (**effect size**). Estos 8 ítems cubren de forma equilibrada los tres clusters diagnósticos cardinales del DSM: 1) Reexperimentación intrusiva (recuerdos dolorosos y reactividad autónoma); 2) Evitación y embotamiento afectivo (evitación de recordatorios, anhedonia y desapego relacional); y 3) Hiperactivación neurovegetativa (insomnio, irritabilidad/ira y respuesta de sobresalto exagerada). Su brevedad y precisión métrica la han convertido en la herramienta de cabecera para monitorizar la eficacia de ISRS y terapia EMDR.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Cluster Sintomático TEPT	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Reexperimentación / Intrusión	2 ítems	0 – 8	Ítem 1 (recuerdos o imágenes dolorosas involuntarias) e Ítem 2 (malestar físico/reactividad somática ante estímulos del trauma).
2. Evitación y Embotamiento	3 ítems	0 – 12	Ítem 3 (evitación activa de lugares/personas), Ítem 4 (anhedonia/pérdida de interés) e Ítem 5 (sensación de distanciamiento/enajenación).
3. Hiperactivación Autónoma	3 ítems	0 – 12	Ítem 6 (dificultades graves para dormir), Ítem 7 (accesos de ira/irritabilidad) e Ítem 8 (sobresalto exagerado / hiperalerta).
Puntuación Total TOP-8	8 ítems	0 – 32	Suma directa simple de los 8 ítems (0-4 cada uno). Indicador ágil de severidad y remisión.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.86 – 0.90	Elevada homogeneidad interna en muestras clínicas en España (Bobes et al., 2000).
Fiabilidad interjueces	CCI = 0.89 – 0.93	Excelente concordancia entre evaluadores clínicos en consultas hospitalarias.
Sensibilidad al cambio terapéutico	Effect size d = 1.35	Rendimiento superior o equivalente a escalas 5 veces más largas en la detección de mejoría.
Validez concurrente	r = 0.92 con DTS (Davidson); r = 0.86 con CAPS	Prácticamente idéntica sensibilidad global que la escala completa de 17 ítems.
Definición de Respuesta Clínica	Reducción $\geq$ 50% del total	Correlación casi perfecta con la impresión clínica de “muy mejorado” en CGI-I.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación dimensional de 5 anclajes (últimos 7 días):**
 - 0 = Nada / Ausente; 1 = Leve / Rara vez; 2 = Moderado ($\geq$ 1 vez por semana); 3 = Grave ($\geq$ 4 veces por semana); 4 = Extremo / Prácticamente diario e incapacitante.
- **Puntuación Total TOP-8:** Suma directa de los 8 ítems (rango posible: 0 a 32 puntos).
- **Criterio Operativo de Remisión Clínica:** Puntuación total $\leq$ 5 puntos (o $\leq$ 7 puntos según baremo estandarizado), con ausencia de cualquier ítem calificado con $\geq$ 3.
- **Criterio de Respuesta Terapéutica:** Reducción $\geq$ 50% de la puntuación basal de la TOP-8 tras un ciclo de 8 a 12 semanas de intervención.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estratificación de Gravedad	Significación Psicopatológica y Estado Clínico
0 – 7 puntos	Remisión / Síntomas Mínimos	Objetivo terapéutico alcanzado. Síntomas residuales sin interferencia en la funcionalidad cotidiana.
8 – 14 puntos	TEPT Leve / Subumbral	Sintomatología atenuada. Buen control conductual pero presencia de tensión o pesadillas ocasionales.
15 – 22 puntos	TEPT Moderado	Cuadro clínico activo florido. Interferencia notable en el rendimiento social y descanso nocturno.
23 – 32 puntos	TEPT Severo / Extremo	Descompensación postraumática grave. Flashbacks diarios, hipervigilancia extrema, anhedonia total e incapacidad funcional.

CRITERIO DE MONITORIZACIÓN DE RESPUESTA (DAVIDSON & COLKET, 1997): Una reducción de $\geq$ 8 puntos respecto a la línea base representa una mejoría clínicamente discernible; alcanzar una puntuación $\leq$ 7 puntos define el estado de remisión terapéutica del TEPT.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Establecimiento de la línea base:

- Administrar la TOP-8 en la sesión inicial tras confirmar diagnóstico de TEPT (mediante CAPS-5 o DTS) y registrar la puntuación basal.

Paso 2: Monitorización quincenal / mensual durante el tratamiento:

- Reaplicar la TOP-8 en cada visita de revisión (3 minutos de administración):
 - **A las 6-8 semanas:** Evaluar si se ha alcanzado una reducción del 30% al 50%. Si la reducción es < 25%, optimizar dosis farmacológica (ej. titular Sertralina a 150-200 mg) o reenfocar el procesamiento del trauma en psicoterapia.
 - **A las 12 semanas:** Verificar si se ha alcanzado la remisión (TOP-8 ≤ 7 puntos).

Paso 3: Plan de mantenimiento o cambio de estrategia:

- Si alcanza remisión: Mantener la pauta de tratamiento farmacológico durante un mínimo de 12 a 24 meses para prevenir recaídas biológicas.
- Si persiste TOP-8 ≥ 15 a pesar de tratamiento de primera línea: Plantear combinación con Terapia de Procesamiento Cognitivo (CPT), EMDR o adición de fármacos de segunda línea (Prazosina para pesadillas o antipsicóticos atípicos a dosis bajas).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 36 años, conductor de ambulancia medicalizada, presenta TEPT grave tras atender un accidente múltiple de tráfico con menores fallecidos hace 4 meses.

Evolución Monitorizada con la TOP-8:

- **Semana 0 (Línea Base): TOP-8 = 27 / 32 (Severo).**
 - Ítem 1 (recuerdos intrusivos) = 4; Ítem 2 (taquicardia al oír sirenas) = 4; Ítem 3 (evitación de autopistas) = 4; Ítems 6 (insomnio) = 4; Ítem 8 (sobresalto extremo) = 4.
- **Intervención:** Inicio de Sertralina 50 mg/día (aumentada a 150 mg/día) y psicoterapia EMDR.
- **Semana 6 de Tratamiento: TOP-8 = 16 / 32 (Moderado).**
 - Reducción del 40.7%. Descenso apreciable del sobresalto (de 4 a 2) y del malestar somático (de 4 a 2).
- **Semana 12 de Tratamiento: TOP-8 = 6 / 32 (Remisión Clínica).**
 - Reducción del 77.8% (> 50% cumplido con éxito). Persiste únicamente insomnio leve residual (ítem 6 = 2) y evitación leve ocasional (ítem 3 = 1). Logró la reincorporación laboral a su puesto sin crisis de angustia.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE SEGURIDAD EN TEPT:

- **Riesgo autolítico elevado:** La desesperanza generada por recuerdos intrusivos masivos (Ítem 1) e insomnio prolongado (Ítem 6) es un disparador de ideación suicida activa.
- **Accesos de ira (Ítem 7 = 4):** Pacientes con hiperactivación extrema pueden presentar reacciones violentas impulsivas o violencia doméstica; evaluar seguridad del entorno.
- **Abuso de alcohol/sedantes:** Muy frecuente para silenciar los flashbacks nocturnos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **TOP-8 vs. PCL-5 / CAPS-5:** La TOP-8 es una escala de monitorización de curso y eficacia; no sustituye a la CAPS-5 para la confirmación diagnóstica formal inicial del Criterio A.
- **Trastorno de Estrés Agudo:** Si la clínica tiene menos de 1 mes de evolución tras el suceso, se tipifica como estrés agudo y no TEPT crónico.
- **Depresión Mayor con rumiaciones:** En la depresión los pensamientos son de culpa o minusvalía existencial, mientras que en el TEPT son reviviscencias sensoriales intrusivas del trauma.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

- Davidson, J. R. T., & Colket, J. T. (1997). The eight-item Treatment-Outcome Post-Traumatic Stress Disorder Scale: a brief measure to assess treatment outcome in PTSD. *International Clinical Psychopharmacology*, 12(1), 41–45. <https://doi.org/10.1097/00004850-199701000-00006>
- Bobes, J., Calcedo-Ordóñez, A., García-Borreguero, D., Francois, M., Rico-Villademoros, F., González, M. P., ... & Grupo de Trabajo de Trastornos por Estrés Postraumático. (2000). Evaluación de las propiedades psicométricas de la versión española de cinco cuestionarios para la evaluación del trastorno de estrés postraumático. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 28(4), 207–218.
- Davidson, J. R. T., Book, S. W., Colket, J. T., Tupler, L. A., Roth, S., David, D., ... & Feldman, M. E. (1997). Assessment of a new self-rating measure for post-traumatic stress disorder: the Davidson Trauma Scale. *Psychological Medicine*, 27(1), 153–160.
- Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.